

Uraz *moralny*

Rdzeń to wstyd i wina za działania sprzeczne z wartościami — nie strach. Inny mechanizm, inna interwencja.

CZAS: 15 min refleksji **REALIZACJA:** 3–6 miesięcy terapii

ŹRÓDŁO: Shay (1994, *Achilles in Vietnam*); Litz i in. (2009, *Clin Psychol Rev*); Dean, Talbot & Dean (2019); Williamson i in. (2020, COVID)

JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy ścieżki** ekspozycji moralnej: zmuszenie do działania sprzecznego z wartościami, bycie świadkiem takich działań, zdrada ze strony systemu. W sekcji 02 — **rozdzielenie** od PTSD i klasycznego wypalenia. Sekcja 03 — pięć kroków pracy z urazem moralnym. Sekcja 04 — twoja refleksja nad konkretnym konfliktem moralnym w pracy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Shay (1994, *Achilles in Vietnam*) opisał *uraz moralny* (ang. *moral injury*) jako specyficzną ranę psychologiczną żołnierzy weteranów: nie strach (jak w klasycznym PTSD), ale **wstyd, wina, utrata zaufania do autorytetów** po doświadczeniu sytuacji, w której własne wartości zostały złamane. Litz i in. (2009, *Clinical Psychology Review*) zoperacjonalizował konstrukt poza kontekstem wojskowym. Trzy ścieżki ekspozycji moralnej: (1) *perpetration* — osoba sama wykonuje działanie sprzeczne z wartościami (lekarz odmawiający pomocy z powodu procedury, terapeuta limitujący sesję mimo kryzysu klienta); (2) *witnessing* — świadkowanie takim działaniom u innych; (3) *betrayal* — zdrada ze strony systemu/autorytetu, który miał chronić wartości. Williamson i in. (2020, badanie pracowników ochrony zdrowia w czasie COVID): masowa ekspozycja na uraz moralny — racjonowanie respiratorów, odmawianie odwiedzin umierającym, decyzje *triage*. Dean, Talbot & Dean (2019): wielu lekarzy określanych jako „wypaleni” w rzeczywistości cierpi z powodu urazu moralnego — co implikuje **inne** postępowanie. Klasyczne interwencje na wypalenie (regeneracja, granice) ani na PTSD (ekspozycja) *nie działają*, bo nie adresują rdzenia: **moralnego pogwałcenia**. Wymagane jest *Adaptive Disclosure* (Litz), praca z winą i wstydem, restytucja, narracja moralna, czasem zmiana środowiska jako akt integralności.

01 Trzy ścieżki ekspozycji moralnej

1 · ZMUSZENIE

perpetration

Sam wykonujesz działanie sprzeczne z wartościami: „skróciłem/-am sesję w trakcie kryzysu, bo grafik”, „odmówiłem/-am pacjentowi pomocy z powodu procedury”. System wymusza wybór, którego nie chcesz, ale dokonujesz go ty.

2 · ŚWIADEK

witnessing

Widzisz, jak inni — koledzy, przełożeni, instytucja — łamią wartości: „zobaczyłem/-am, jak traktują pacjentów po godzinach”. Cierpisz, choć sam/a nie jesteś sprawcą. Pytanie: czy zareaguję, czy zachowam milczenie.

3 · ZDRADA

betrayal

System lub autorytet, który miał chronić wartości, sam je łamie: „dyrekcja zignorowała alarm bezpieczeństwa pacjentów”. Cierpienie miesza się z gniewem na zdradzony idealizm. Ta ścieżka generuje najsilniejszą utratę zaufania.

02 ? Rozróżnienie — uraz moralny vs PTSD vs wypalenie

URAZ MORALNY

Rdzeń: wstyd, wina, utrata zaufania.

Co czujesz: „nie powinienem/-am był/a tego zrobić”.

Interwencja: *Adaptive*

Disclosure, praca z winą, narracja moralna, restytucja.

PTSD

Rdzeń: strach, hiperaktywacja, intruzje.

Co czujesz: „grozi mi niebezpieczeństwo, jestem w pułapce”.

Interwencja: ekspozycja, przetwarzanie traumy, regulacja.

WYPALENIE

Rdzeń: wyczerpanie + cynizm + spadek skuteczności.

Co czujesz: „nie mam już siły, wszystko bez sensu”.

Interwencja: regeneracja, granice, zmiana w pracy.

Klinicznie kluczowy test: czy cierpienie wynika z *przeciążenia* (wypalenie), z *strachu* (PTSD) czy z *łamania wartości* (uraz moralny)? Te trzy mogą współwystępować — wymagają jednak różnych interwencji jako rdzennych.

03 ☉ Pięć kroków pracy z urazem moralnym

1 • ROZPOZNAJ

Czy moje cierpienie wynika z przeciążenia, czy z łamania wartości? Jeśli wstyd, wina, gniew na siebie dominują nad zmęczeniem — to prawdopodobnie uraz moralny.

2 • NAZWIJ KONFLIKT

Jakie konkretne wartości są łamane? „*Cenię obecność dla pacjenta — system wymaga mnie 15-minutowych wizyt*”. Nazwa odbiera bezgłośność.

3 • ODDZIEL ODPOWIEDZIALNOŚĆ

„*Czy miałem/-am realny wybór?*” System-wina nie jest twoja-wina. Praca nad odróżnieniem odpowiedzialności osobistej od strukturalnej jest kluczowa, by wstyd nie pochłonął tożsamości.

4 • DZIAŁAJ

Trzy poziomy: zmiana systemu od wewnątrz (rzecznictwo, zespół), ochrona własnych granic moralnych, w skrajnych przypadkach — odejście jako akt integralności.

5 • PRZETWARZAJ

Terapia ukierunkowana na uraz moralny (*Adaptive Disclosure*, narracja moralna). Pisanie. Rozmowy z zaufanymi kolegami w tym samym zawodzie. Grupy etyczne (np. grupy Balinta dla lekarzy). To proces miesięcy, nie tygodni.

04 ✎ Twoja refleksja — konkretny konflikt moralny

KONKRETNA SYTUACJA

— moment, w którym poczułeś/-aś łamanie wartości w pracy

WARTOŚĆ, KTÓRA ZOSTAŁA NARUSZONA

— np. obecność, profesjonalizm, godność pacjenta, sprawiedliwość

MÓJ REALNY WYBÓR W TEJ SYTUACJI

— co konkretnie zależało ode mnie, a co od systemu

MÓJ NASTĘPNY KROK

— rzecznictwo wewnątrz, ochrona granic, ewentualnie konsultacja zewnętrzna

Klucz: uraz moralny nie jest słabością. Jest sygnałem, że *twój kompas moralny działa*. Osoby pracujące w trudnych systemach **bez** tego cierpienia są w bardziej niepokojącym stanie — zwykle oznacza to znieczulenie albo wczesny etap moralnego wycofania. Ból moralny boli, bo wartości są obecne. Cel pracy klinicznej z urazem moralnym nie polega na „pozbyciu się” bólu — polega na **integracji** doświadczenia: zachowaniu wartości bez samodestruktywnego wstydu, na rozróżnieniu odpowiedzialności osobistej od strukturalnej, na znalezieniu drogi do dalszego działania zgodnego z tym, kim jesteś.